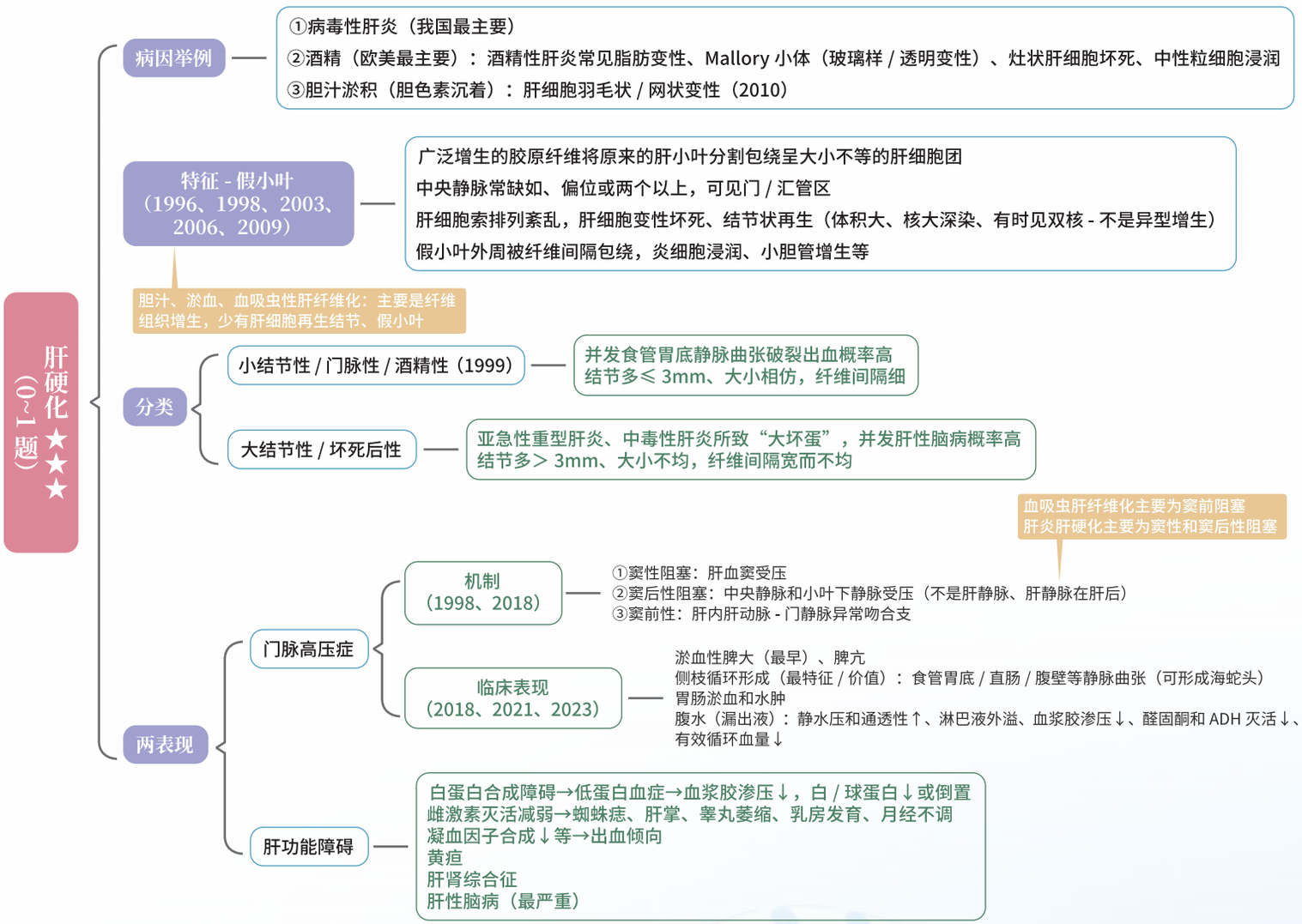

肝硬化 ★★★（0~1题）
病因举例
①病毒性肝炎（我国最主要）
②酒精（欧美最主要）：酒精性肝炎常见脂肪变性、Mallory 小体（玻璃样 / 透明变性）、灶状肝细胞坏死、中性粒细胞浸润
③胆汁淤积（胆色素沉着）：肝细胞羽毛状 / 网状变性（2010）
特征 - 假小叶（1996、1998、2003、2006、2009）
广泛增生的胶原纤维将原来的肝小叶分割包绕呈大小不等的肝细胞团
中央静脉常缺如、偏位或两个以上，可见门 / 汇管区
肝细胞索排列紊乱，肝细胞变性坏死、结节状再生（体积大、核大深染、有时见双核 - 不是异型增生）
假小叶外周被纤维间隔包绕，炎细胞浸润、小胆管增生等
胆汁、淤血、血吸虫性肝纤维化：主要是纤维组织增生，少有肝细胞再生结节、假小叶
分类
小结节性 / 门脉性 / 酒精性（1999）
并发食管胃底静脉曲张破裂出血概率高
结节多≤ 3mm、大小相仿，纤维间隔细
大结节性 / 坏死后性
亚急性重型肝炎、中毒性肝炎所致“大坏蛋”，并发肝性脑病概率高
结节多＞ 3mm、大小不均，纤维间隔宽而不均
血吸虫肝纤维化主要为窦前阻塞
肝炎肝硬化主要为窦性和窦后性阻塞
两表现
门脉高压症
机制（1998、2018）
①窦性阻塞：肝血窦受压
②窦后性阻塞：中央静脉和小叶下静脉受压（不是肝静脉、肝静脉在肝后）
③窦前性：肝内肝动脉 - 门静脉异常吻合支
临床表现（2018、2021、2023）
淤血性脾大（最早）、脾亢
侧枝循环形成（最特征 / 价值）：食管胃底 / 直肠 / 腹壁等静脉曲张（可形成海蛇头）
胃肠淤血和水肿
腹水（漏出液）：静水压和通透性↑、淋巴液外溢、血浆胶渗压↓、醛固酮和 ADH 灭活↓、有效循环血量↓
肝功能障碍
白蛋白合成障碍→低蛋白血症→血浆胶渗压↓，白 / 球蛋白↓或倒置
雌激素灭活减弱→蜘蛛痣、肝掌、睾丸萎缩、乳房发育、月经不调
凝血因子合成↓等→出血倾向
黄疸
肝肾综合征
肝性脑病（最严重）